

Dementsusega inimeste ja omastehooldajate vajadused

Merle Varik, MSW

doktorant, Tallinna Ülikooli
ühiskonnateaduste instituut
lektor, Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Kai Saks, PhD

geriaatria dotsent,
Tartu Ülikooli sisekliinik

Marju Medar, PhD

dotsent, Tallinna Ülikooli
ühiskonnateaduste instituut

Artiklis antakse ülevaade uurimistulemustest dementsussündroomiga lähedasi hooldavate omastehooldajate olukorra ning võimestamise viiside kohta ning tuuakse välja olulisemad arendamist vajavad valdkonnad.

Aastal 2015 oli maailmas 47 miljonit dementsuse diagnoosiga inimest, prognooside kohaselt tõuseb see arv järgmise 20 aasta jooksul 132 miljonini (*Global action...* 2017).

Juba 2012. aastal seadis Maaailma Terviseorganisatsioon (MTO) dementsusega seonduva rahvatervise prioriteediks. MTO on rõhutanud, et riikidel tuleb arendada tervishoiu ja hoolekande sidusust, sh suurendada spetsialistide teadlikkust, pöörata rohkem tähelepanu omastehooldajate ja dementsusega inimeste võimestamisele, teavitustööle kogukonnas ning haiguse varajasele diagnoosimisele ja ravile (*Dementia...* 2012). Riiklik dementsuse strateegia on olemas 30 Euroopa riigis, Eesti paraku nende hulka ei kuulu (Alzheimer Europe 2017).

MTO kinnitas dementsuse tegevusplaani aastateks 2017–2025. Selles soovitatakse kõigile riikidele võtta dementsust kui rahvatervise prioriteeti; parendada teadlikkust ja dementsussõbralikkust; haiguse ennetamist ja diagnoosimist; ravi ja hooldust; omastehooldajate nõustamist ja koolitamist;

asjakohase informatsiooni kättesaadavust ja teadustegevust (*Global action...* 2017). Rõhutatakse ka seda, et korrektne on kasutada stigmatiseeriva mõiste „dementne” asemel kas **dementsusega** või **dementsussündroomiga** inimene/klient/patsient/eakas.

Ka Eestis on dementsuse temaatika viimase kümne aasta jooksul päevakorda tõusnud võimsamalt kui kunagi varem. Kogukonna, omavalitsuste, erialaspetsialistide ja riigi tasandil on hakatud rääkima dementsusega inimeste omaste hoolduskoormuse vähendamisest, toetavate teenuste kättesaadavuse parandamisest ja täienduskoolituste vajadusest. Valitsus on otsustanud toetada kompetentsikeskuse loomist ning arendada hoolekandetöötajate täienduskoolitust. On asutatud MTÜ Elu Dementsusega, mis koondab nii omakseid kui ka spetsialiste. Samas tuleb tõdeda, et epidemioloogilisi uuringuid dementsussündroomi kohta ei ole Eestis seni läbi viidud. Linnamägi ja Asser (2004), kes esimeste seas uurisid dementsusega inimeste pereliikmetest hooldajaid, tõdesid, et hoolduskoormuse

Dementsussündroom

Dementsus ei ole omaette haigus, see koondab erinevaid sümptomeid ehk haigustunnuseid, mis on omavahel seotud ja võivad olla põhjustatud mitmetest haigustest. Teisisõnu on tegemist sündroomiga, mis häirib inimese argitoiminguid ja mille levimus kasvab koos eaka elanikkonna suurenemisega.

Laialt on käibel väärarusaam, et dementsus on vananemisega kaasnev iseärasus, mitte haigustest põhjustatud seisund, ja seetõttu inimesed ei pöördugi arsti poole. Tõsi, haigused, mis võivad põhjustada dementsust, sagenevad vanemas eas. Dementsus ei teki aga lihtsalt vanadusest, vaid on haigustest (neid on üle 50) põhjustatud sündroom. Enamik nendest haigustest on progresseeruvad, mistõttu inimese iseseisev toimetulek ajapikku halveneb. Umbes 10–20% haigustest, mis põhjustavad dementsussündroomi, on põhimõtteliselt ravitavad. (Saks jt 2016, Tripathi ja Vibha 2009). Ülejäänud haigustele efektiivset ravi kahjuks veel ei ole.

Kõige sagedasem dementsuse põhjus on vanemas täiskasvanueas tekkiv Alzheimeri tõbi, mis moodustab ligi 60% kõigist dementsuse juhtumitest. Alzheimeri tõvega kaasnevad tavaliselt kognitiivsed sümptomid: **amneesia** (mälu ebaloomulik halvenemine), **agnoosia** (suutmatus ära tunda asju, isikuid ja kohti), **afaasia** (oskamatus kasutada kõnet või sellest aru saada) ning **apraksia** (võimetus eesmärgipärast ja varem osatud motoorset tegevust planeerida ning lõpule viia). Lisaks täheldatakse ka psüühika- ja käitumishäireid: isiksuse muutust, **agiteeritust** (ebakohane motoorne või sõnaline käitumine); luulumõtteid, mis on tavaliselt paranoilise iseloomuga ning põhjustavad sageli agressiivset käitumist. Inimesel on kalduvus ekslemiseks, sh soov või vajadus kuhugi minna, võib esineda ka unehäireid, depressiooni, motoorikahäireid, neelamisraskusi ja inkontinentsust ehk uriinipidamatust (Saks jt 2016, Boltz ja Galvin 2016).

Sündroomi algetapis halveneb mälu, alaneb reaktsioonikiirus, ilmnevad meeleolulangus ja ärevus, kuid inimene tuleb toime lihtsamate argitoimingutega, abi on vaja vaid keerulisemate ülesannete puhul. Seetõttu ei märka tihti ei lähedased ega ka sotsiaal- või tervishoiutöötajad, et midagi on valesti. Haiguse arenedes unustamine süveneb, kõne aeglustub, otsustusvõime ja ka inimese emotsionaalne suhe omastega halveneb. Kui inimesel tekivad raskused ajas ja kohas orienteerumisega, siis märkavad ka lähedased probleemi tõsidust. On oluline märkida, et loetletud tunnused ei esine sugugi kõigil haigetel ning nende tekkimise järjekord või kaasuvad ilmingud sõltuvad dementsuse vormist ja isiksusest. Haiguse progresseerudes tekib mingil hetkel täielik hooldusvajadus. Siis vajavad omaksed abi ja nõustamist nii sotsiaal- kui tervishoiutöötajatelt. Kohe, kui täheldatakse, et inimesel on igapäevaelu häiriv kognitiivse võimekuse langus, on vaja haigus diagnoosida ning alustada raviga. Ravimitega on võimalik mõne aasta jooksul sümptomite süvenemist pidurdada, millega koos vähenevad ka omastehoolduse ja formaalse hoolduse kulud (Vähi jt 2007). Haiguse tuvastamine varajases faasis lisab inimese elukvaliteedile väärtuslikke aastaid.

seost võimaliku tulevase tervisekaona ei ole seni teadvustatud ühiskonda mõjutava probleemina. Saks jt (2007) toovad välja, et dementsusega inimese hooldamisel vajavad pereliikmed nii psühhosotsiaalset toetust ja nõustamist kui ka mitmesuguseid teenuseid, sh kättesaadava hinnaga koduabiteenust.

Viimastel aastatel on kaistud mõned magistritööd ja korraldatud ka muud uuringud dementsussündroomiga lähedasi hooldavate omastehoolajate olukorra kohta ning nüüd on asjakohane senised tulemused ja soovitusel üle vaadata. Artiklis peatume pikemalt ka värskel uuringul, mis pakub uut teavet omastehoolajate vajadustest ja võimestamise viisidest ning toome välja olulisemad arendamist vajavad valdkonnad.

Varasemad uuringud

Linnamägi ja Asser nentisid juba 2004. aastal, et diagnoosini jõuab väga väike osa haigetest: Alzheimeri tõbi on aladiagnoositud, dementsuse spetsiifiliste vormide kriteeriume ei tunta. Möödunud on 15 aastat, kuid haigusstatistika ei kajasta jätkuvalt tegelikku olukorda. Eeldades, et meil sarnaneb dementsussündroomi levimus teiste Euroopa riikide näitajatega, võiks Eestis olla arvutuslikult kuni 13 000 dementsusega inimest (*Alzheimeri tõve ...* 2017).

Aladiagnoosimise põhjus võib olla inimeste vähenenud teadlikkus dementsust põhjustavatest haigustest ja nende ravivõimalustest ja nii ei pöördutagi arsti poole. Kütt (2017) uuris Eesti perearstide arusaamu Alzheimeri tõve skriiningutestide kohta. Ta tõdes, et perearstid peavad haiguse võimalikult varajast avastamist tähtsaks, ent ei tunne end diagnoosimisel kindlalt ega suuna kõiki haiguskahtlusega patsiente uuringutele, kuna Eesti eri piirkondades ei jätku selleks pädevaid spetsialiste.

Rahvusvaheliste uuringute andmetel hooldatakse ligi 75% dementsussündroomiga

inimestest kodus. Omastehoolajatel lasub siin suur koormus ja vastutus. Sageli on hooldajaks üks perekonnaliige või lähedane, kes vastutab ka tehtud otsuste eest. Hoolduskoormust mõjutavad hooldaja varasemad kogemused, hooldatava tervislik seisund ja tema võime sooritada argitoiminguid, probleemse käitumise esinemine, hoolduse kestus ja intensiivsus. Hooldamisega kaasnevad nii füüsilised, vaimsed, sotsiaalsed kui ka materiaalsed raskused, mis mõjuvad sageli halvasti hooldaja majanduslikule olukorrale, tööelule, peresuhtele, heaolule ja tervisele. (*Dementia...* 2012, Boltz ja Galvin 2016, Cox 2007, Stensletten jt 2016, Karlsson jt 2015, Zabalegui jt 2014).

Eesti uuringutele tuginedes võime öelda, et lähedasele hooldajaks olemine toob kaasa psüühilise- ja füüsilise ülekoormuse ja rollikonflikti ning ebakindluse hoolduse järjepidevuse ja kättesaadavuse suhtes (Toivari 2012, Saks jt 2007, Karabelnik 2012, Linnamägi ja Asser 2004). Omastehoolajad muretsesvad hooldatava turvalisuse pärast ning püüavad vastavalt oma oskustele ja võimalustele kodus võimalikke riske vähendada. Oluliseks peetakse nii lähivõrgustiku kui ka kogukonna toetust. Samas on omastehoolajad kurnunud, et abi otsides on nad saanud ka negatiivseid kogemusi, kui spetsialist ei süvenenud olukorda või käitus ebaprofessionaalselt. (Toivari 2012).

Asutushooldusele paigutamise otsust ei tehta kergelt, sest omastehoolajad kahtlevad, kas see on eaka heaolu arvestades parim võimalik valik (Karabelnik 2012). Ka Saks jt (2007) on välja toonud, et lähedased eelistavad hooldada oma dementsusega pereliikmeid võimalikult kaua kodus, kuid nad vajavad koduhooldaja abi, päevakeskusteenust, intervallhoolduse võimalust ja nõustamist. Hooldusasutusse soovitakse pöörduda siis, kui on kindlustunne, et pereliikme eest

hoolitsetakse seal hästi (Toivari 2012, Saks 2007). Armoliku ja Kiige (2011) uurimus näitas, et üldhooldekodud ei pakkunud dementsusega inimestele sobivat hooldust. Nendega tegeldi vaid niivõrd, kuivõrd selleks igapäevase töö kõrvalt aega ja oskusi jätkus, pigem üritasid töötajad toime tulla klientide haigustest ja käitumisest tulenevate iseärasuste ja tagajärgedega. Uuringu autorid leidsid, et tähelepanu keskmes peaksid olema keskkonna turvalisus ja hoolduspersonali teadlikkus dementsuse olemusest, kliendikeskne lähenemine ja eaka parem toimetulek.

Olukorra saab kokku võtta rahvusvahelise teadusprojekti RightTimePlaceCare (2010–2013) tulemuste põhjal. Nende järgi on Eestis võrreldes seitsme Euroopa riigiga formaalseid teenuseid saavate dementsusega inimeste kognitiivne võimekus ja elukvaliteet kõige halvem, suremus kõige kõrgem, omastehooldajate koormus koduhoolduses kõige suurem, dementsusega inimeste professionaalne hooldus 2–5 korda vähem rahastatud, halvasti kättesaadav ja vähe koordineeritud (Beerens jt 2013, Wübker jt 2015, Verbeek jt 2015, Karlsson jt 2015, Lethin jt 2016). Suure hoolduskoormuse tõttu oli meie omastehoolajate tervis halvem ja tervishoiukulutused kasvasid (Bremer jt 2015). Selgus ka see, et Eestis ja Hollandis teevad tervishoiu- ja hoolekandetöötajad ühesuguste juhtumite puhul oluliselt sagedamini otsuse hooldus-asutuse kasuks võrreldes teiste riikidega. Seejuures on aga motiivid erinevad: Eestis on põhjuseks puuduvad või raskesti kättesaadavad koduteenused, Hollandis eeskätt kättesaadav ja hea kvaliteediga asutushooldus (Saks jt 2015). Kõik see viitab, et Eestis on vaja kiiresti parandada teenuste kättesaadavust ja teenuste valikut, et järele jõuda Euroopa keskmisele.

Uurimus hooldamisel kogetust

Kirjeldatava uurimuse (Varik 2017)¹ eesmärk oli saada ülevaade dementsusega inimeste omastehoolajate kogemustest ja nende muutuvatest vajadustest. Veebruarist kuni aprillini 2017 koguti individuaalintervjuudena 16 omastehoolaja narratiive Tartus, Tallinnas, Haapsalus, Võrus ja Valgas. Valim oli eesmärgipärane ning kasutati ka lumepalli meetodit – uurimuses osalejad soovitasid uusi intervjuueeritavaid. Valiku kriteeriumid olid järgmised: vähemalt pool aastat omastehooluse kogemust, millest ei olnud möödunud rohkem kui pool aastat; hooldataval oli diagnoositud dementsus või esinesid kognitiivsest langusest tulenevad toimetulekuprobleemid; hooldatav oli vanem kui 50 aastane ning intervjuu toimus eesti keeles. Uuritavate leidmiseks koostati kuulutus, mis saadeti omastehoolajate ühingutele, ja mida jagati sotsiaalmeedias MTÜ Elu Dementsusega lehe kaudu ning edastati neuroloogi vastuvõtule dementsusega isikuga kaasa tulnud omastele.

Intervjuueeritavate vanus oli 33–86 aastat, hooldati kas oma vanemat, vanavanemat(id), abikaasat, õde või tädi. Nad jagasid oma hoolduskogemusi ning pakkusid välja teenuseid ja tegevusi, millega saaks omastehoolajaid võimestada. Intervjuu kestus varieerus 90 minutist 140 minutini. Andmeid koguti küllastumiseni, st kuni ei ilmnunud enam uut informatsiooni. Lood salvestati ja litereeriti, andmete analüüsimisel kasutati avatud kodeerimist ning temaatilist analüüsi.

Tulemused

Diagnoosini jõudmine ja informatsiooni vajadus. Uurimusest selgus, et omaksed

¹ Uurimus on osa tegevusuuringust, kus töötatakse välja Eesti jaoks sobivad dementsusega inimeste omastehoolajate võimestamise võimalused.

hakkavad otsima professionaalset abi siis, kui dementsus süveneb ning inimesel on tekkinud juba tõsisemad probleemid. Diagnoosi panemine oli mõnes mõttes kergenduseks, sest võimaldas mõista, miks inimene käitub varasemast teistmoodi. Kõigis intervjuudes rõhutati, et esmajoonel tunti vajadust info järele, mis aitaks mõista, mida diagnoos endaga kaasa toob. Puudust tunti ka nõuannetest ja soovitustest, kust abi saada ning kuidas oma lähedast hooldada. Nii nagu eelnevalt viidatud uurimistulemustes, heitsid omastehooldajad ette arstide, õdede või sotsiaaltöötajate vajaka-jäämisi info jagamisel: „Arst oli ikka imelik, ütleski, et on dementsus, aga mis vorm, sellel pole tähtsust, et on nagu on /.../. Eks me olime šokeeritud, et äkki läheb üle. Siis me olime internetis õega ja otsisime infot ja materjale.” (R2, 47a, ema hooldaja).

„Võib olla see neuroloogi juures käimine. /.../ Tegelikult oleks võinud seal tähelepanu olla ka omastele. Et mis ootab ees, mis järgmisena kaob /.../ ehmatust oleks vähem olnud. Saime soovitusi ainult, et õppige luuletusi.” (R4, 43a, aitab hooldada tädi).

Kõigil intervjuueeritavatel oli peamiseks teabeallikaks internet. Omastele on kindlasti abiks, kui lisaks räägitule jagatakse ka kirjalikku infomatsiooni ning antakse juhiseid, kuidas ja kust leida lisateavet haiguse ja teenuste kohta.

Eestis puudub tugisüsteem, kuhu spetsialistid võiksid saata dementsusega inimese või tema omaksed diagnoosijärgsele nõustamisele või koolitusele. „Ei sotsiaaltöötaja, ei perearst osanud tegelikult aidata. Jah, nad olid väga abivalmis sedasama kättesaadavat infot jagama; perearst oli valmis andma saatekirju ja suunamisi igale poole, kuhu vaja oli, psühhiaatrile, diakooniahaiglasse, sotsiaaltöötaja printis hooldekodude nimekirja... Aga sellist sisulist abi või edasisuunamist pole.” (R6, 48a, ema hooldaja).

„Vaja oleks mingit keskust. Lähen teatud aja tagant uuesti ning siis tehakse uuringud, et tema seisundit dünaamiliselt hinnata. See aitab aru saada, mis on läinud kehvemaks, mis ees ootab. Mind aitaks see teadmine, see kinnitaks, et ma pole midagi valesti teinud. Et personaalselt tegeletakse inimesega, korrigeeritakse ravi ja nõustatakse. Ma saaksin siis ennetada ehk neid uusi langusi või olla nendeks valimis.” (R12, 54a, ema hooldaja).

Vastutuse võtmine pereliikme hooldamise eest. Pereliikme haigestumine muudab pere omavahelisi suhteid ja senist elukorraldust. Lisaks uuele hooldaja rollile tuleb täita oma seniseid rolle, millega tihti kaasneb koormatus ja emotsionaalne pinge. Sageli on hooldajaks üks kindel lähedane, kes võtab hooldusega seotud otsuste eest vastutuse. Kuna ta on haiguse kohta rohkem uurinud, siis tuleb tal ka teisi sugulasi emotsionaalselt toetada ning aidata neilgi haigusest aru saada. „Kogu koormus ja vastutus on minu peal. Tuli vennal kõigepealt aidata aru saada, mis haigus see on ja kuhu kõik välja viib. See oli kõige raskem, et ise pidi nagu tugev olema ja muudkui seletad ja rahustad, et jah, ema ongi praegu selline närviline ja kiuslik ... et see on haigusest.” (R6, 48a, ema hooldaja).

Hoolduskoormust tajutakse pingelisemana, kui hooldamine on intensiivne ja kogemust ei ole. Mida halvemaks muutub hooldatava kognitiivne seisund, seda tähtsamaks muutuvad kõik hooldatava ja tema tervisega seotud aspektid. Pinge tõusu kogetakse siis, kui eakas ei saa enam argielu toimingutega hakkama või muutub agressiivseks. Selles etapis otsitakse olukorrale lahendusi ja kombineeritakse neid omavahel, kasvab vajadus lisainfo ja toetuse järele. „Esiteks see oli šokk ema jaoks, kes näeb, et tema vanemad tülitsevad ja vanaisa lööb. Ema langes depressiooni lõpuks. /.../ Ta ei osanud käituda, et mida teha ja küsida ei

olnud ka kellegi käest. Ema oleks vajanud juhendamist, kuidas hooldada, missuguseid mähkmeid valida, kuidas neid vahetada ja kuidas ka vanaisaga käituda... jne.” (R15, 38a, aitas vanaisa-vanaema hooldada).

Oma abikaasat hooldades kogeti seda kui kooselu loomulikku osa ning abistaja ja hoolitseja rolli täideti pühendumisega. „Mis mind on jalul hoidnud, on see, et ma kõige selle juures olen lülitanud ennast lihtsalt tema aitamise. Ma ikka ütlen, et sina oled esiplaanil ja mina olen järjekorras. See ei tähenda, et sa ise oma hädade ja kõige sees ei ela, vaid elad selle teise inimese hädades. /.../”. (R5, 86a, abikaasa hooldaja).

Hoolduskoormuse mõju vaimsele tervisele. Hoolduskoormus mõjub negatiivselt ka omastehooldajate tervisele, neil võib esineda stressi sümptomeid ja ka depressiooni. Puudust tuntakse võimalusest sõpradega aega viita või huvialadega tegelda. Üks pensionieas ja lapsed suureks kasvatanud intervjuueeritu rääkis, et ta on jätnud oma vanema hooldamisel isikliku elu ja vajadused teadlikult tagaplaanile ning keskendunud lähedase hooldamisele, mis samas on emotsionaalselt kurnav ning mõjub vastuoluliselt. „Emotsionaalselt ongi raske. /.../ Kõige kurvem on see, et mu oma elu on selles mõttes häiritud, et mul on mees surnud ja ma elan täiesti üksinda. Oleks olnud võimalus endale kaaslane leida... aga jällegi on takistuseks ema, sest kunagi ma ei tea, kuna ma pean ta enda juurde võtma ning millal me enam hakkama ei saa ning siis on see mõeldamatu. Selles mõttes isiklikku elu ei ole. Kõik taandub sõnale ema.” (R7, 67a, ema hooldaja).

Pingeid tekitavad ka olukorrad, kus teised lähedased, kes igapäevaselt hooldatavaga kokku ei puutu või suhtlevad ainult telefonitsi, võtavad dementsusega isiku räägitut tõena. Tuttavate süüdistav suhtumine on omastehooldajale emotsionaalselt rusuv ja

olukorra selgitamine võib kaasa tuua lisa-pingeid: „/... / helistab sõbrannale, et kõik on nii halvasti ning kurdab, et mis temaga siin kõik ikka tehakse halba. /.../ raske on teistele selgeks teha, et mis on õige ja mis mitte. Siis tullaksegi ütleva, et mis mõttes te niimoodi teete ja olete sellised hoolimatud.” (R3, 33a, elukaaslase vanaema hooldaja).

Emotsionaalne pinge ei kao pärast hoolduse lõppemist. Hooldatava surm on hooldaja jaoks uus olukord, sest ta peab kohanema eluga ilma hoolduskohustuse ja hooldatavata, millega sageli kaasneb enesesüüdistus. Seda võimendab ka tuttavate ja lähedaste suhtumine hooldekoduteenusesse. „Siitamaani on emal süütunne. Ta tunneb, et ta ei saanud hakkama, et ta polnud piisavalt hea /.../. Ja kui me vanaisa lõpuks hooldekodusse panime, kusjuures me olime väga rahul selle hooldekoduga, siis ema nuttis väga, kui üks sugulane ütles, et miks sa enda juurde ei võta. /.../ Ta arvas, et kõik vaatavad matustel, et näed nüüd surigi seal hooldekodus ära....” (R15, 38a, aitas vanaisa-vanaema hooldada).

Töö ja hooldamise ühitamine ning töökaaslaste toetav suhtumine. Kui hooldaja töötab täiskoormusega, siis töötab ta topeltkoormusega ning paratamatult mõjub see halvasti. Töö ja hoolduse ühitamine on keeruline, kuigi püütakse igati kohandada tekkinud koormuse ja pingega. „Tavaline oligi, et peale tööpäeva lõppu proovisid nii, et ikka peale kella viit saaks püsti tõusta. Enam ei saanud endale lubada pikki tööpäevi /.../ püüdsid kõik koosolekud ära lõpetada, olid närviline ja jooksid ning siis olid liiklusummikud.../.../. Ja siis olid õnnelik, kui ükskord ema juurde jõudsid hooldekodusse /.../ Üheksa ajal kodus siis vaatasid, et mis jäid veel kella viiestest tööasjadest. Praegu ikka mõtlen, et kuidas ma üldse vastu pidasin.” (R9, 52a, ema hooldaja).

Samas mõjus hästi töökaaslaste toetav suhtumine, mis aitas natukegi tasakaalu leida. Olles ise juba hooldamise alal mõnes mõttes ekspert, jagati teavet ka abi vajavatele kolleegidele. „Töö juures ollakse toetavad. Kui on vaja kuskile minna emaga või mingid asjaajamised, siis saan alati minna. Ja on ka teisi kolleege, kellel on samasugused probleemid, siis räägime. Nemad küsivad minu käest, et mis nüüd teha... ma olen ka jaganud intervallhoolduse kohta infot ja päevakeskuse kohta.” (R12, 54a, ema hooldaja).

Toetavate sotsiaalteenuste vajadus.

Lugudest selgus, et Eestis ei ole dementsusega inimestele ja nende omastele piisavalt teenuseid või on nende kättesaadavus piiratud. Omastehooldajatele on oluline ülevaatlik informatsioon erinevatest võimalustest ning et antaks konkreetseid soovitusi, suunamisi või koolitusi. Meie võimalusi võrreldi teistes riikides pakutavaga, selles valdkonnas oodatakse arengut ka Eestis.

„Sotsiaalosakonnas käituti minuga väga hästi, aga abi oli, jah, null. Otsime hooldajat koju, et saaks nende kaudu ja siis öeldi, et mitte mingil juhul, tal on lapsed olemas. Ma ütlesin, et me ise maksaksime ju. Ning siis öeldi, et see oleks teie jaoks liiga odav (!)” (R2, 47a, ema hooldaja).

„Sotsiaalabi osakonnas peaks olema kompaktelt info väljas, et mis võimalused on, kui mul on selline juhtum, et ma ei avastaks seda kogemata ja juhuslikult, et seda infot, mis võimalused, et kus abi saaksin. Ma nt teadsin küll ja et seal on päevakeskus, aga ma arvasin, et sinna saavad minna ainult need, kes ise kõnnivad sinna.” (R12, 54a, ema hooldaja).

„Mul on sõbrad Ameerikas, kellel naisel diagnoositi haiguse esimesed märgid ja need süsteemid on nii teistsugused, et kuidas nad hakkasid siis kohe käima ühes koolis, et piken-dada toimetulekut ning õpetada abikaasat ka.

Ja milleks tuleb valmistuda inimesele ja tema lähedastel,” (R4, 43a, aitab hooldada tädi).

Intervjuueeritavad olid väga tänulikud, kui nende elukoha omavalitsus oli loonud dementsusega inimeste päevakeskuse. Samuti toonitati intervallhoolduse tähtsust, sest see teenus võimaldas ajutiselt koormust leevendada. „Intervallhooldus... kuidas aitab! See annab võimaluse, et saan minna kodust ära ööseks /.../. Ta vennaga ei lepi... läheb paanikasse ja närvi. /.../ Olen võtnud puhkuse endale teadlikult 10päevaseks reisiks. Kahjuks saan seda kasutada ainult üks kord aastas. Ja muidugi päevakeskuse võimalus on ka lähedastele suureks abiks.” (R12, 54a, ema hooldaja).

Kaalutusotsused asutushooldus versus omastehooldus.

Dementsuse süvenedes ja koormuse suurenedes kaalutakse üha sagedamini võimalust paigutada hooldatav asutushooldusele. Seda aeglustavad pikad järjekorrad ja ebapiisav informatsioon, probleemiks on ka teenuse kõrge hind ning seetõttu püütakse nii kaua, kui on võimalik, ise hakkama saada. Nii nagu varasemateski Eesti uuringutes, selgus taas, et hooldekodud ei vastanud omastehooldajate ootustele või tunti selle ees hirmu. Nenditi Eesti mahajäämust võrreldes teiste riikidega, kus on paremad võimalused dementsusega inimeste igapäevaelu toetamiseks. „Hooldekodu otsingud olid väga keerulised. Dementsusega inimesele mõeldud osakondi on vähe ja enamuses kohtades on väravad ja ukSED avatud ning ei tea ka, kuidas teenuse kvaliteet on. Hooldekodudes panustatakse hooldajatele, aga ei ole tegevusterapeute või -juhendajaid. Hooldajate töö oleks ju ka lihtsam, kui inimesed on tegevuses. /.../ Kannatlikkust, teadlikkust ja sõbralikkust on vaja selles töös. Meil ei ole selliseid kohti nagu nt Dementia Village või võimalust, kus elavad koos nt üliõpilased ja vanad. Ning järjekorrad on ka pikad, vähemalt 2 kuud. Ega infot ka ei

ole. Istud ja hakkad järjest helistama.” (R6, 48a, ema hooldaja).

„Sõitsime läbi Lõuna-Eesti hooldekodud ning olukord on seinast-seina. Sellega seoses siis ei tahaks nagu igale poole panna. Ja teiseks see võtab aega, enne kui koht vabaneb. Et ei ole jah väga roosiline see olukord siin Eestis.” (R4, 43a, aitab hooldada tädi).

Asutushoolduse kasuks on raske otsustada. Koormus küll väheneb, ent hooldaja jaoks ei pruugi pinge kaduda. Lähedased soovivad mingilgi määral kontrollida hoolduse kvaliteeti või siis arvatakse, et parimat hooldust pakuksid nad ikkagi ise. Sageli on rahulolematust seotud hooldatava turvalisuse ja aktiveerivate tegevuste vähesusega, kardetakse, et hooldekodusse minek mõjub omakse seisundile halvasti. Kogetud on ka rahustite väärkasutamist. „Hooldekodus tekkis probleeme ravimitega. Läksin päeval vaatama ja talle oli ravimeid antud, mida ei olnud ette nähtud /.../ Tal oli hästi korralikult see raviskeem, just tema jaoks kohandatud ja raviarst ütles ka, et lugege hooldekodule sõnad peale, et ära ei rikuks seda /.../ Tajusin, et midagi on valesti. Lähed kell kaks vaatama, ta on täiesti lääbakil, ei saa sõnagi suust ja magab püstijalu. Hakkad rääkima ja uurima ning siis üks hooldaja lobises kogemata välja, et annavad haloperidoli, kuigi hiljem nad eitasid seda, sest ega seda tal ju raviskeemis ei olnud. See oli selline hästi kurb hetk.” (R9, 52a, ema hooldaja).

Koolitustes ja tugigruppides osalemise vajadus. Rahvusvaheliste uuringute andmeil on omastehooldajate võimestamisel häid tulemusi andnud tugigruppide, koolituste, nõustamist jm meetmeid hõlmavate sekkumiskavade rakendamine. Nende abil saab ennetada või vähendada stressi, ärevust, läbipõlemist ja terviseriske ning anda teavet dementsussündroomi ja hooldusprotsessi kohta (Boltz ja Galvin

2016, Cox 2007, Stensletten jt 2016, Zabalegui 2014, Lethin 2016). Omastehooldajad töid esile vajaduse koolituste ja tugigruppide järele. Neis osalemine annab lähedastele lisainfot, jagatakse ka omi kogemusi. Eelmisel aastal alustas Eestis MTÜ Elu Dementsusega tugigruppide kohtumisi Tallinnas, Tartus, Võrus ja Kuressaares. See ettevõtmine on saanud väga head vastukaja. Sel aastal on kavas teha rohkem teavitustööd kogukonna tasandil.

„Tugigrupis on hea ise rääkida ja kuulata teiste lugusid, see on toetav. Arvan, et see kogemus, et tuleme kokku ja igaüks kurdab – seda on ka vaja. Et kui sul on raske, peadki seda tundma, et sul on raske, sest muidu sa sellest tundest lahti ei saagi, seda on vaja kindlasti. Kasvõi seda, et siis näed, et kellelgi on veel raskem kui minul.” (R6, 63a, abikaasa hooldaja).

Oluline on ka lähedaste ja naabrite abineering toetus. Kogukondlik abi on omastehooldajate võimestamisel üks kasutamata ressurss, niisamuti kaaskodanike tähelepanelik suhtumine ja märkamine. „Oleme naabritega rääkinud, et nemad hoiavad ka silma peal. Meie naabrimees on kogu aeg kodus. Kui kuuleb, et signalisatsioon läheb tööle, siis tuleb vaatama ja annab teada meile ning samas vaatab ringi ka kohe. /.../ Selles mõttes on ikka rahulikum töö olla ka.” (R3, 33a, elukaaslase vanaema hooldaja).

Kokkuvõte ja järeldused

Toetudes varem korraldatud uuringutele ning hiljuti läbi viidud intervjuudele võime järeldada, et dementsusega inimestele kvaliteetsete teenuste pakkumiseks ja omastehooldajate võimestamiseks tuleb tegutseda järgmistes valdkondades:

- 1) sotsiaal- ja tervishoiutöötajate professionaalsuse tõstmine täiendus- ja tasemeõppe kaudu
- 2) integreeritud ja innovaatiliste teenuste arendamine ja nende kättesaadavuse tagamine, sh tuleb arendada mitmesuguseid

- sotsiaalteenuseid ja teha need ka hinna poolest kättesaadavaks
- 3) omastehooldajate ja dementsusega inimeste teavitamine sotsiaaltöötaja poolt abi saamise / toetamise võimalustest, sh asjakohane info teenuste kohta tuleks kokku koondada ja teha kättesaadavaks; luua keskused, kuhu on koondunud pädevad spetsialistid; arendada välja integreeritud (tervishoiu)teenus, mille kaudu saaks teavet kognitiivsete häirete diagnostika, ravi ja juriidiliste küsimuste puhul
 - 4) omastehooldajate võimestamine koolituste, nõustamise ja tugigruppide kaudu, sh korraldades koolitusi, et inimesed mõistaksid dementsussündroomi ja saaksid teadmisi, kuidas säilitada hooldatava kognitiivset võimekust nii, et ta võimalikult kaua osaleks hooldusprotsessis aktiivse partnerina; toetama peaks omastehooldajate psühho-sotsiaalset toimetulekut sh teraapiagrupid
 - 5) avalikkuse teavitamine ja kogukonnatöö, sh tuleks rohkem ja avatumalt rääkida normaalsest vananemisest ning haigusega kaasnevatest probleemidest eri meediakanalites, jagada kogemuslugusid, et kujuneks dementsusega inimestesse sõbralikult suhtuv ühiskond; leida võimalusi kogukonnatööks
 - 6) välisriikide eeskujul tuleks meilgi teenuste arendamisse kaasata dementsusega inimesi ning uurida, missugused on nende ootused.

Teiste riikide eeskujul on vaja koostada pikemaajaliste tegevussuundade selgitamiseks riiklik dementsuse strateegia ning teha rahvusvahelist koostööd, osaledes teadusuuringutes ja arendusprojektides ning rakendades paremaid praktikaid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et dementsusega inimeste hooldusega seotud probleemid ja omastehooldajate toetusvajadused on viimase 10–15 aasta jooksul jäänud üsna muutmatuks. Vajadus teenuste kättesaadavuse parandamiseks ning uute teenuste rakendamiseks on ilmne. Oluline on, et sotsiaaltöö- ja tervishoiuspetsialistidel, kes oma töös puutuvad kokku dementsussündroomiga (nt sotsiaalnõustamisel, juhtumikorralduses, koordineerides koduteenuseid, hooldamist perekonnas, rehabilitatsiooniteenuseid jne) oleks piisavalt teadmisi ja oskusi, et aru saada haiguse olemusest ja omastehooldajate võimestamisest. On tarvis ka tugiteenuseid, kuhu klienti suunata. Võtmeprobleemideks oli, on ja jääb sotsiaaltöö- ja tervishoiuspetsialistide koostöö ning dementsusega inimeste lähivõrgustiku kaasamine. **S**

Südamlik tänu omastehooldajatele, kes osalesid uurimuses ning MTÜ Elu Dementsusega liikmetele.

Viidatud allikad

- Alzheimer Europe.** (2017). National Dementia Strategies. www.alzheimer-europe.org/Policy-in-Practice2/National-Dementia-Strategies (12.01.2018).
- Alzheimeri töve diagnostika ja ravi.** (2017). Ravijuhendite nõukoda.
- Armolik, A., Kiik, R.** (2011). Dementsusega eakate hoolduse olukord üldhooldekodus Tartu maakonna näitel. *Sotsiaaltöö* 1, 44–54.
- Beerens, H. C., Zwakhalen, S. M., Verbeek, H., Ruwaard, D., Hamers, J. P.** (2013). Factors associated with quality of life of people with dementia in long-term care facilities: a systematic review. *International Journal of Nursing Studies* 50(9), 1259–1270.
- Boltz, M., Galvin, J. E.** (toim). (2016). *Dementia Care. An Evidence-Based Approach*. Springer International Publishing AG.

- Bremer, P., Challis, D., Hallberg, I. R., Leino-Kilpi, H., Saks, K., Vellas, B., Zwakhaleng, S. M. G., Sauerland, D., (2017). Informal and formal care: Substitutes or complements in care for people with dementia? Empirical evidence for 8 European countries. *Health Policy* 121 (2017) 613–622.
- Cox, C. B. (2007). *Dementia and Social Work Practice. Research and Interventions*. Springer Publishing.
- Dementia: a public health priority*. (2012). World Health Organization.
- Global action plan on the public health response to dementia 2017–2025*. (2017). World Health Organization.
- Karabelnik, K. (2015). Mitteformaalsete hooldajate narratiivid dementsusega eaka pereliikme hooldamise kogemusest. Tütarde ja abikaasade vaatenurk. Magistritöö. Tartu Ülikool.
- Karlsson, S., Bleijlevens, M., Saks, K., Martin, M., Stephan, A., Suhonen, R., Zabalegui, A., Hallberg, I. (2015). Dementia care in European countries, from the perspective of people with dementia and their caregivers. *Journal of Advanced Nursing* 71, (6), 1405–1416.
- Kütt, M. L. (2017). Improvement opportunities for Alzheimer's disease screening and diagnostics in Estonia: Family physicians' perceptions. Master's Thesis. Tallinn University of Technology
- Lethin, C., Leino-Kilpi, H., Roe, B., Soto, M. E., Saks, K., Stephan, A., Zwakhalen, S., Zabalegui, A., Karlsson, S. (2016). Formal support for informal caregivers to older persons with dementia through the course of the disease: an exploratory, cross-sectional study, *BMC Geriatrics* 16: 32.8
- Linnamägi, Ü., Asser, T. (2004). Dementne inimene – koormus ühiskonnale. *Eesti Arst*, 83 (4), 256–261.
- Saks, K., Tammaru, M., Tiit, E.-M., Võrk, E. (2007). Dementsusega inimeste hooldamise probleemid ja hooldusteenuste arendamise vajadus Eestis. Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon.
- Saks, K., Tiit, E.-M., Verbeek, H., Raamat, K., Armolik, A., Leibur, J., Meyer, G., Zabalegui, A., Leino-Kilpi, H., Karlsson, S., Soto, M., Tucker, S. RightTimePlaceCare Consortium. (2015). Most appropriate placement for people with dementia: individual experts' vs expert groups' decisions in eight European countries. *Journal of Advance Nursing* 71, 6, 1363–1377.
- Saks, K., Maimets, T., Tamm, R., Uiho, R., Pääsuke, M., Tulviste, T., Soots, A., Sakkeus, L., Tambaum, T., Medar, M., Tulva, T., Murov, A. (2016). Gerontoloogia. Õpik kõrgkoolidele. Saks, K. (toim). Tartu Ülikooli Kirjastus.
- Stensletten, K., Bruvk, F., Espehaug, B., Drageset, J. (2016). Burden of care, social support, and sense of coherence in elderly caregivers living with individuals with symptoms of dementia. *Dementia: The International Journal of Social Research and Practice*. 15, (6), 1422–1435.
- Tripathi, M., Vibha, D. (2009). Reversible dementias. *Indian Journal of Psychiatry* 51(1), 552–555.
- Zabalegui, A., Hamers, J. P., Karlsson, S., Leino-Kilpi, H., Renom-Guiteras, A., Saks, K., Soto, M. E., Sutcliffe, C., Cabrera, E. (2014). Best practices interventions to improve quality of care of people with dementia living at home. *Patient Education and Counseling* 95, 175–184.
- Toivari, T. (2012). Dementsusega inimeste omashooldajate kogemused hooldajaks olemisest ja professionaalse abi saamisest: parim praktika, probleemid ja ettepanekud tulevikuks. Magistritöö. Tartu Ülikool, arstiteaduskond, õendusteaduse osakond.
- Vähi, M., Kirsimägi, Ü., Braschinsky, M. (2007). Alzheimeri tõve ravi memantiiniga Eestis: farmako-ökonoomiline hindamine. *Eesti Arst* 86 (2), 94–99.
- Verbeek, H., Meyer, G., Challis, D., Zabalegui, A., Soto, M. E., Saks, K., Leino-Kilpi, H., Karlsson, S., Hamers, J. P. (2015). Inter-country exploration of factors associated with admission to long-term institutional dementia care: evidence from the RightTimePlaceCare study. *Journal of Advanced Nursing* 71(6), 1338–1350.
- Wübker, A., Zwakhaleng, S. M., Challis, D., Suhonen, R., Karlsson, S., Zabalegui, A., Soto, M., Saks, K., Sauerland, D. (2015). Costs of care for people with dementia just before and after nursing home placement: primary data from eight European countries. *The European Journal of Health Economics*. 16(7), 689–707.